

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

RINOSINUSITIS

Introducción

La rinosinusitis (RS) es la inflamación sintomática de la mucosa de las fosas nasales y senos paranasales, se caracteriza por presentar los siguientes síntomas (dos o más): obstrucción o congestión nasal, hiposmia o anosmia, rinorrea anterior o posterior, sensación de presión facial o dolor. Se puede asociar **signos endoscópicos** (presencia de pólipos, rinorrea mucopurulenta en meato medio y edema de la mucosa del meato medio) y/o **alteraciones en TAC de senos paranasales** (cambios en ostiomeatal y/o en la mucosa de los senos). Se clasifica:

Según el seno afectado en: etmoidales, maxilares, frontales y esfenoidales.

Según el tiempo de evolución pueden ser:

- **Aguda:** si la duración de los síntomas es inferior a 12 semanas, sus síntomas desaparecen de forma completa. El origen puede ser **vírico (resfriado común)**: los síntomas pueden durar 10 - 15 días. **Bacteriano:** Los síntomas empeoran a los 5 días o persisten 10 -15 días.
- **Crónica:** si la duración de los síntomas es mayor de 12 semanas y no desaparecen y pueden empeorar de forma transitoria.
- **Recurrente:** si se presenta tres o más episodios agudos al año

Diagnóstico

Se basa en la clínica, fundamentalmente en la anamnesis y la exploración clínica con rinoscopia, preferible endoscopia. No son necesarias las pruebas de imagen complementarias a menos que:

- Se sospeche complicación, a pesar de haber recibido tratamiento adecuado y la evolución es desfavorable.
- Presente afectación sistémica o estemos frente a paciente con inmunodepresión, en estos caso deberá de solicitarse:
- TC de senos paranasales.
- La Rx simple de senos paranasales tiene alto índice de falsos positivos y negativos.

SINUSITIS AGUDA

Introducción

Inflamación de la mucosa de uno o más senos paranasales. Los senos maxilares son los que con más frecuencia se afectan. El resfriado común es la causa más frecuente que provoca la inflamación de la mucosa y la obstrucción del drenaje de los senos. También existen otras causas como: rinitis alérgica, los pólipos nasales, las alteraciones anatómicas, los tumores, los traumatismos, el exceso de uso de descongestionantes nasales e inmunodeficiencias sistémicas y locales.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico. Presenta clínica de obstrucción nasal, secreción bilateral, presión o algia facial, fiebre.

Viral: síntomas durante menos de 10 días y sin empeoramiento de la clínica.

Bacteriano: síntomas persistentes durante más de 10 días o persistentes con empeoramiento.

Rinoscopia anterior: mucosa edematosa y secreciones purulentas. Palpación de puntos sinusales.

Tratamiento

RSA: tratamiento sintomático con analgésicos, corticoides intranasales a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal 1 ó 2 veces al día e irrigación con agua salina diaria.

RSBA: sin complicaciones, elegir entre tratamiento sintomático (siempre que haya seguimiento en 7 días) o tratamiento sintomático más antibiótico (Amoxicilina con o sin Ácido clavulánico c/8h durante 5-10 días). Si es alérgico a penicilina se puede usar las quinolonas como: Levofloxacino, moxifloxacino. Si persisten los síntomas en 7 días, añadir otro antibiótico o cambio de línea. Cefalosporinas de 2ª generación: cefuroxima o cefpodoxima.

Si paciente con infección severa con mala respuesta al tratamiento inicial, con sospecha o presencia de complicaciones usar cefalosporina 3ª generación vía parenteral: ceftriaxona IV o cefotaxima IV asociado a vancomicina. Si se sospecha de sinusitis odontógena asociar ATB frente a anaerobios: asociar amoxilina y metronidazol. La duración del tratamiento deberá ser entre 10 - 14 días y por lo general mantener el ATB 7 días después de obtener mejoría clínica.

SINUSITIS CRÓNICA

Introducción

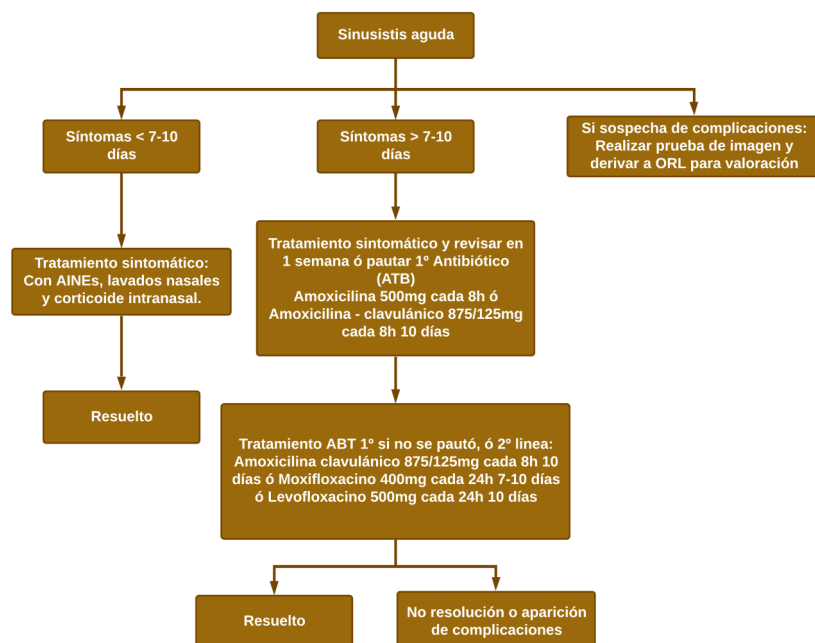
Síntomas durante más de 12 semanas, objetivados mediante exploración con rinoscopia anterior, endoscopia y tomografía axial computarizada.

Diagnóstico

Actitud en urgencias: solicitar seguimiento por consulta de ORL.

Nota

- En ningún caso el diagnóstico de sinusitis se fundamentará en una imagen radiológica alterada.



COMPLICACIONES DE LA SINUSITIS

Introducción

Son poco frecuentes, no superan el 5% de los casos. Siempre derivar a ORL.

Las complicaciones pueden ser locales, orbitarias e intracraneales. Siendo las orbitarias y las intracraneales las más frecuentes.

1. Complicaciones locales

Mucoceles que dependiendo del seno afectado generarán diferentes síntomas.

2. Complicaciones orbitarias (3%)

Necesitan una atención inmediata. Más frecuente en inmunosuprimidos. 5 grados según la clasificación de Chandler:

Grado	Descripción
I	Celulitis preseptal
II	Celulitis orbitaria
III	Absceso subperióstico
IV	Absceso orbitario
V	Trombosis séptica del seno cavernoso

Diagnóstico

- anamnesis, exploración ORL y Oftalmológica.
- Edema periorbitario, proptosis y fiebre. Después diplopía, disminución de agudeza visual, oftalmoplegia...
- Pruebas de imagen: TAC de elección.

Tratamiento

- Antibioticoterapia intravenosa (IV): cefalosporinas de 3º generación: ceftriaxona 2 gr IV.

3. Complicaciones intracraneales (<1%).

Introducción

Meningitis, osteomielitis, trombosis del seno dural, absceso intracraneal, abscesos epidurales, subdurales y cerebrales. Son emergencias fatales.

Diagnóstico

Es clínico fundamentalmente.

- Examen físico completo con valoración de pares craneales y estado neurológico.
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica básica con PCR, coagulación.
- Punción lumbar.
- TAC Craneal.

Tratamiento

Antibioticoterapia empírica IV a altas dosis según hallazgos de punción lumbar, generalmente ceftriaxona o cefepima, con posible cobertura añadida con vancomicina. Valorar drenaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cuvillo A, Soto JG. Rinitis y rinosinusitis, “rasgos tratables” del asma. Rev Asma. 2018;3(2):55-69.
- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Capítulo 102. Madrid. 2015.
- Suárez Nieto C, Gil-Carcedo García L.M, Marco Algarra J, Medina J. E, Ortega del Álamo P, Trinidad Pinedo J. Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Edición 2, Editorial Panamericana. Año 2009.
- Shah K, Stanley Shapshay R, “Acute laryngitis” Emedicine; Web MD, 2006
- Cobeta Marco, I. Otorrinolaringología y patología cervicofacial. Ars Médica, 2003